

Nódulo pulmonar

≤3 cm

Um guia calmo para quem recebeu este achado no exame.
Não substitui a avaliação do seu médico.

A primeira coisa a saber: encontrar um nódulo no pulmão é comum. Ele aparece em até metade dos adultos que fazem raio-X ou tomografia do tórax, e **na grande maioria das vezes não é câncer**. Mesmo assim, o achado merece ser revisto com calma por um especialista.

1 • O que é?

Uma pequena mancha arredondada no pulmão, com **até 3 cm** (acima disso, o nome passa a ser “massa”). Quase sempre aparece por acaso, num exame feito por outro motivo. Nódulos pequenos não causam dor, tosse nem falta de ar.

2 • Quase sempre benigno

Menos de 5 em cada 100 nódulos acabam sendo câncer. Nos nódulos bem pequenos (menores que 5 mm), o risco é menor que 1 em 100. Muitos são apenas uma cicatriz antiga, já quieta.

3 • Por que aparece?

Causas frequentes: cicatriz no pulmão, infecção antiga já curada (às vezes sem nunca ter dado sintomas), como pneumonia ou tuberculose, granuloma e inflamação. Às vezes é um câncer em fase inicial, e por isso existe o acompanhamento.

O que o especialista observa

Cada nódulo é avaliado junto com a sua história

- **Tamanho:** nódulos bem pequenos são os de menor preocupação. Os sólidos menores que 6 mm, em pessoas de baixo risco, muitas vezes nem precisam de nova tomografia.
- **Tipo e formato:** se é sólido ou “em vidro fosco” (mais clarinho). Bordas lisas e regulares tendem a ser mais tranquilas do que bordas irregulares.
- **Exames antigos:** comparar com imagens anteriores mostra se o nódulo já existia. Um nódulo sólido que **não cresce em 2 anos** é considerado benigno. Os em vidro fosco crescem mais devagar e podem ser acompanhados por até 5 anos.
- **Seu histórico:** idade, tabagismo, câncer de pulmão na família, câncer anterior ou imunidade baixa entram na conversa, sem alarme automático.

O que fazer agora

Com calma, um passo de cada vez

- 1 Guarde o exame completo: **laudo e imagens** (CD, pendrive ou acesso ao portal do laboratório).
- 2 Marque consulta com **pneumologista ou cirurgião de tórax**. Leve exames de tórax anteriores, se tiver, mesmo os antigos.
- 3 O médico decide se basta acompanhar com novas tomografias ou se é preciso outro exame. **A maioria das pessoas com nódulo não precisa de biópsia.**
- 4 Se você fuma, este é um ótimo momento para parar. Peça ajuda à sua equipe.
- 5 Evite procurar sozinho imagens e histórias na internet. O contexto do seu caso é o que importa.

Acompanhar não é “deixar para depois”

Muitas vezes, o plano é repetir a tomografia depois de alguns meses para ver se o nódulo mudou. Esperar esse intervalo é seguro: mesmo quando é um câncer inicial, ele costuma continuar pequeno e com boa chance de cura nesse tempo. **Não crescer ao longo do tempo é um sinal muito tranquilizador.** Quem define o intervalo é o especialista, e é importante não faltar aos exames combinados.

Não espere a data do retorno se

Surgir **sangue no catarro**, falta de ar ou dor no peito que pioram, ou **perda de peso sem explicação**: procure seu médico. Se houver falta de ar intensa ou muito sangue no catarro, vá ao pronto-socorro.

Evite

- Concluir sozinho que “é câncer” ou que “não é nada”.
- Interromper o acompanhamento por medo do resultado.
- Comparar o seu laudo com histórias da internet.

Prefira

- Levar o exame a um especialista em pulmão.
- Anotar suas dúvidas para a consulta.
- Cuidar do que está sob o seu controle: não fumar, mexer o corpo, dormir bem e manter as consultas em dia.